



O Segundo Cérebro dos Eventos

LIVEBOOK

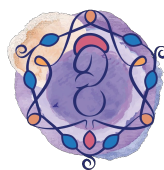
A Reforma Obstétrica no Brasil

Análise epistemológica, mapa de evidências e agenda de pesquisa para o leitor acadêmico

Palestrante

Luciane da Silva D'Avila

Enfermeira Obstétrica · Presidente da ABENFO Nacional



Siaparto

São Paulo / SP · 2025

Posicionamento Bibliográfico

Onde esta palestra se inscreve na produção contemporânea sobre saúde materna

A palestra de Luciane D'Avila se inscreve no campo da saúde coletiva brasileira em diálogo direto com a literatura internacional sobre modelos obstétricos liderados por parteiras (midwifery models of care). Mais especificamente, opera como articulação política e técnica do consenso global cristalizado em três marcos editoriais que estruturam o debate desde a década de 2010: a Lancet Series on Midwifery (Renfrew et al., 2014), o State of the World's Midwifery 2021 (Nove et al., 2021) e, mais recentemente, o Global Position Paper da Organização Mundial da Saúde sobre Transitioning to Midwifery Models of Care (WHO, 2024), com seu guia de implementação publicado em 2025 (WHO, 2025).

No campo brasileiro, a palestra dialoga com a tradição de pesquisa epidemiológica em saúde materno-infantil consolidada em torno do projeto Nascer no Brasil (Leal et al., 2014; 2019) e sua segunda edição em curso, com a produção crítica sobre violência obstétrica (Diniz et al., 2015; Lansky et al., 2019) e com a literatura sobre racismo obstétrico que ganhou densidade analítica nos últimos cinco anos (Lima et al., 2021; Souza & Gallo, 2022). Politicamente, articula-se ao Manifesto Reforma Obstétrica no Brasil Já! (Rede Feminista de Saúde, ABENFO, REHUNA, 2025) e à atualização normativa representada pela Resolução COFEN nº 737/2024, que regulamenta o parto domiciliar planejado.

A escolha do termo "Reforma Obstétrica" é, em si, uma operação retórica deliberada: importa do campo da saúde mental brasileira, no rastro de Amarante (1996, 2007), o vocabulário e a gramática conceitual da Reforma Psiquiátrica — desinstitucionalização, mudança de paradigma, modelo contra-hegemônico, transição assistencial. Esta filiação é mais do que estilística; sinaliza o framework analítico no qual a palestrante se posiciona, e que será explicitado adiante na seção sobre Quadro Teórico Implícito.

Para o leitor pesquisador, vale antecipar que a palestra é predominantemente expositiva e mobilizadora — não traz novos achados empíricos primários, e sim sistematiza, do ponto de vista da liderança da ABENFO, um corpo de evidências e

propostas já consolidado internacionalmente, contextualizando-o para o cenário brasileiro. Seu valor analítico está na articulação entre dado epidemiológico, recomendação internacional e diagnóstico de configuração política nacional. O Livebook, na seção a seguir, sintetiza criticamente essa operação.

Síntese Crítica

Tese central, estrutura argumentativa e contribuição

Tese central

A tese central da palestra pode ser formulada em uma sentença: o Brasil só conseguirá reduzir significativamente sua mortalidade materna e neonatal e adequar suas taxas de cesariana se promover uma reforma estrutural do modelo obstétrico, transitando do paradigma hospitalocêntrico e médico-centrado para um modelo coordenado por enfermeiras obstétricas e obstetrites, com integração colaborativa entre profissões e organizado em arranjos regionais diversificados.

Esta tese é apresentada como conclusão necessária a partir de quatro eixos argumentativos articulados: (1) o diagnóstico do modelo brasileiro atual, com seus indicadores estagnados ou em piora; (2) o histórico das políticas públicas que tentaram reformá-lo sem sucesso (PAISM, Rede Cegonha, Rede Alyne); (3) o consenso internacional consolidado em torno do midwifery model of care, especialmente as posições da OMS, UNFPA e ICM; e (4) a configuração política nacional atual, que abriu janela para a apresentação do Manifesto pela Reforma Obstétrica ao Ministério da Saúde em 2025.

Estrutura argumentativa

A construção do argumento segue uma estrutura clássica de retórica reformista: começa pela nomeação do problema (taxas de mortalidade materna, cesariana, planejamento reprodutivo, desigualdades raciais), passa pela genealogia das tentativas anteriores e suas insuficiências (avaliação crítica das redes brasileiras), avança para a apresentação do paradigma alternativo já validado em outros contextos (modelos internacionais), e culmina na proposta de transição com mecanismos políticos concretos (manifesto, articulação com o COFEN, audiências públicas, formação de especialistas).

Operação retórica notável: a palestrante mobiliza repetidamente a fórmula "não sou eu que digo, são os organismos internacionais que dizem", ancorando suas afirmações em fontes externas (OMS, UNFPA, ICM) para deslocar o debate do campo da disputa

corporativa interna entre enfermeiras e médicos para o campo da adequação a parâmetros técnicos consolidados internacionalmente. Esta é uma operação deliberada de despolitização aparente, que serve à repolitização efetiva do tema em outro registro — o do compliance internacional e dos compromissos ODS.

Contribuição da palestra

No plano da contribuição, a palestra opera em três níveis simultaneamente. No nível conceitual, sistematiza para o público brasileiro uma síntese acessível do paradigma midwifery model of care e o batiza, no contexto nacional, como Reforma Obstétrica — operação de tradução cultural relevante, ainda que carregada de pressupostos teóricos que merecem escrutínio (ver Quadro Teórico Implícito). No nível político, mapeia o estado atual do movimento pela reforma — atores, alianças, conquistas recentes, próximos passos institucionais — funcionando como atualização para profissionais e ativistas. No nível mobilizador, performa a convocação à associação e à participação ativa na ABENFO, articulando a defesa da reforma à valorização e ao fortalecimento da entidade representativa da categoria.

Para o leitor acadêmico, a palestra tem valor sobretudo como objeto de análise sociológica do movimento reformista brasileiro em curso, mais do que como fonte primária de evidência empírica ou inovação teórica. Ela documenta, em registro próprio, como uma liderança corporativa formula publicamente a posição da entidade num momento de janela política específica.

Sobre a Palestrante

Trajetória institucional e produção

Luciane da Silva D'Avila é enfermeira obstétrica, atualmente Presidente da ABENFO Nacional (Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras), entidade que congrega enfermeiras obstetras, obstetrizes e enfermeiras neonatais. Atua há mais de duas décadas em saúde da mulher, com formação e atuação em Santa Catarina, e possui histórico de articulação institucional entre a categoria profissional e os órgãos reguladores e governamentais — em especial o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Ministério da Saúde.

Sua trajetória recente é marcada pela articulação política em torno da Reforma Obstétrica: na entrega do manifesto ao Ministro da Saúde Alexandre Padilha em 2025 (com a Rede Nacional Feminista de Saúde e a REHUNA), na audiência pública na Câmara dos Deputados sobre o tema (proposta pela deputada federal Ana Paula Lima), na obtenção do endosso institucional do COFEN ao manifesto e na articulação junto à SGTES/MS para a formação de novos especialistas. É também referência reconhecida em formação continuada — incluindo cursos sobre Implanon na Amazônia, mencionado na palestra — o que evidencia atuação que articula advocacy nacional com formação técnica em territórios específicos.

Para o leitor pesquisador, vale registrar que a palestra é proferida na posição institucional de presidência de entidade representativa, e não na posição de pesquisadora. Isto não desqualifica o conteúdo, mas é um dado importante para a leitura: a palestra sistematiza posição da ABENFO, com seleção e ênfases coerentes com essa função, e não tem pretensão de ser revisão neutra da literatura. As referências à academia aparecem majoritariamente em chave instrumental — apoio à argumentação reformista — e não em chave investigativa.

Quadro Teórico Implícito

Paradigmas e tradições mobilizados (mesmo quando não nomeados)

Embora a palestra não explicita seu quadro teórico em registro acadêmico, é possível identificar pelo menos quatro tradições conceituais que estruturam, de modo articulado, o argumento. Mapeá-las contribui para situar a palestra na geografia teórica do campo e abrir caminho para análise crítica posterior.

A analogia com a Reforma Psiquiátrica brasileira

A escolha do termo Reforma Obstétrica não é casual. A palestrante explicita: "a gente já teve algumas reformas, por exemplo, a reforma psiquiátrica, que teve toda uma conceitualização, que teve todo um modelo descrito. E eu acho que é muito baseado nisso que a gente hoje fala em reforma obstétrica". Essa filiação convoca todo um aparato conceitual: o vocabulário basagliano de desinstitucionalização (Basaglia, 1985 [1968]), a leitura brasileira da reforma psiquiátrica formulada por Paulo Amarante (1996; 2007), a noção de modelo contra-hegemônico, o paradigma da atenção psicossocial em substituição ao manicomial. Transposta ao campo obstétrico, essa gramática orienta o diagnóstico do hospital obstétrico convencional como "instituição total" análoga ao manicômio, da medicalização do parto como análoga à medicalização do sofrimento psíquico, e da centralidade da gestante como paralela à centralidade do sujeito em sofrimento. É filiação teórica fortemente carregada — implica leitura estrutural do problema, não meramente assistencial.

O paradigma do midwifery model of care

O segundo quadro teórico, este internacional, é o paradigma do cuidado centrado na parteira, sistematizado pela Lancet Series on Midwifery (Renfrew et al., 2014). Esta série propõe um framework de qualidade do cuidado materno e neonatal (Quality Maternal and Newborn Care Framework — QMNCF) construído em torno de cinco componentes: práticas, organização, valores, filosofia, provedores. Nele, o cuidado obstétrico é definido por habilidades, atitudes e comportamentos, não por papéis profissionais específicos — o que permite operacionalizar a transição entre modelos sem reduzi-la a disputa corporativa. A palestra opera nesse paradigma de modo direto, embora não cite a

referência: as falas sobre "cuidado liderado por enfermeira obstétrica", "autonomia profissional", "colaboração interprofissional" e "modelo coordenado por parteiras" são tradução fiel deste framework.

A determinação social da saúde materna

Atravessando os dois primeiros, o terceiro quadro é o da determinação social da saúde, na tradição da saúde coletiva latino-americana (Almeida-Filho, Buss & Pellegrini Filho, entre outros). Este quadro orienta a leitura dos indicadores brasileiros — mortalidade materna, taxa de cesariana, adequação do pré-natal — não como problemas técnicos isolados, mas como manifestações de iniquidades estruturais: raça, classe, território, acesso. A insistência da palestrante nas desigualdades raciais (74% de gestações não planejadas em mulheres negras, mortalidade materna duas vezes maior, apenas 8% de adequação do pré-natal) é manifestação direta deste quadro.

A gramática dos direitos humanos e da justiça reprodutiva

Por fim, atravessa toda a palestra a gramática dos direitos reprodutivos e dos direitos humanos no parto, herdada do trabalho de organizações como a Rede Nacional Feminista de Saúde, a REHUNA e o sistema interamericano de proteção (caso Alynne Pimentel vs. Brasil, primeira condenação internacional do país por morte materna evitável, 2011). Esta gramática introduz no debate a categoria do consentimento informado, da autonomia da gestante, da violência obstétrica como violação de direitos — e oferece a base conceitual para a interlocução com Defensoria Pública das Mulheres e com instâncias internacionais de monitoramento.

Tensão entre os quadros

Vale notar, finalmente, que esses quatro quadros não são plenamente comensuráveis entre si. A analogia com a Reforma Psiquiátrica enfatiza a ruptura paradigmática e o conflito hegemônico. O paradigma midwifery model of care, na versão WHO/UNFPA, enfatiza a integração colaborativa e a transição negociada. A determinação social pede leitura estrutural; os direitos humanos pedem leitura individualizada do consentimento. A palestra costura esses registros pragmaticamente, sem tematizar suas tensões — o que é prerrogativa do gênero discursivo conferência política, mas é fricção produtiva para análise acadêmica posterior.

Tópicos da Palestra

Análise por eixo argumentativo, com mapa de evidências por afirmação

Esta seção destrincha os oito eixos argumentativos centrais da palestra. Cada subtópico segue a mesma estrutura: análise do conteúdo apresentado, articulação conceitual e mapa de evidências organizado em quatro registros — afirmação central, literatura de apoio, literatura que tensiona ou matiza, e questões em aberto no debate atual. Conforme alinhado para este perfil de leitor, o livebook não emite julgamento próprio sobre a validade das afirmações; mapeia o estado da literatura indexada e devolve ao leitor a tarefa de avaliação crítica.

1. Reforma Obstétrica como categoria política e técnica

A palestrante opera a categoria "Reforma Obstétrica" em paralelismo deliberado com a Reforma Psiquiátrica brasileira: ambas seriam transições paradigmáticas de um modelo hospitalocêntrico para um modelo descentralizado, comunitário e baseado em direitos. O Manifesto Reforma Obstétrica no Brasil Já! — elaborado pela Rede Nacional Feminista de Saúde com apoio da ABENFO e da REHUNA, e endossado por mais de 27 instituições — é a expressão organizada dessa categoria, com três pleitos centrais: inserção de enfermeiras obstetras e obstetrizes no SUS com atuação longitudinal; fomento à formação especializada; criação de grupo de trabalho no Ministério da Saúde para a reforma.

Politicamente, o termo Reforma diferencia-se de Política, Programa ou Rede: implica mudança estrutural de paradigma, não apenas redesenho de fluxos ou serviços. É operação de batismo deliberada — converte o que poderia ser lido como atualização técnica de protocolos em movimento social organizado.

Mapa de evidências

Afirmação central da palestra: a Reforma Obstétrica é o caminho viável e necessário para reduzir a mortalidade materna e neonatal e adequar a assistência ao parto no Brasil.

Literatura de apoio: documentos de posicionamento internacional convergem nessa direção, com destaque para o Global Position Paper da OMS sobre Transitioning to Midwifery Models of Care (WHO, 2024) e o State of the World's Midwifery (Nove et al., 2021); no Brasil, o Manifesto Reforma Obstétrica no Brasil Já! (Rede Feminista de Saúde et al., 2025) sintetiza o pleito, com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e do projeto Nascer no Brasil (Leal et al., 2014).

Literatura que tensiona ou matiza: parte da literatura sobre reforma psiquiátrica brasileira (Amarante, 2007; Delgado et al., 2007) aponta que processos de desinstitucionalização sustentáveis requerem três décadas e ainda assim permanecem incompletos — alerta relevante sobre as condições e o tempo necessários para transições paradigmáticas no SUS. Estudos sobre experiências de integração (Goodarzi et al., 2022) também sugerem que modelos colaborativos consolidados convivem com tensões corporativas persistentes.

Em aberto no debate atual: qual é o desenho institucional brasileiro mais adequado para sustentar a transição (centralizado pelo MS? federativo via CIT? bottom-up por experiências locais?); como articular reforma com o sistema de saúde suplementar, que opera com lógica econômica diversa do SUS; e como evitar repetição dos limites observados na implementação da Rede Cegonha.

2. Diagnóstico do modelo obstétrico brasileiro vigente

A palestra apresenta um diagnóstico em cinco indicadores articulados: planejamento reprodutivo precário (55% das gestações não planejadas, 74% entre mulheres negras), baixa prevalência de métodos contraceptivos de longa duração (cerca de 2%), adequação do pré-natal entre 15% e 21% dos cuidados recomendados (8% entre mulheres negras), taxa de cesariana de aproximadamente 59%, e violência obstétrica persistente, com vítimas concentradas em mulheres negras. A hipótese explicativa avançada é que esses indicadores não são dispersos: configuram um modelo coerente, hospitalocêntrico e médico-centrado, que reproduz desigualdades estruturais e resiste a correção apenas pela via de políticas pontuais.

O diagnóstico é apresentado em chave epidemiológica, mas com leitura sociológica subjacente: as desigualdades raciais nos indicadores não são tratadas como ruído estatístico, mas como manifestação de racismo institucional na saúde — leitura que dialoga com a literatura sobre racismo obstétrico (Lima et al., 2021; Souza & Gallo, 2022).

Mapa de evidências

Afirmação central da palestra: os indicadores brasileiros configuram um modelo obstétrico estruturalmente disfuncional, marcado por sobre-medicalização, sub-cuidado e desigualdade racial.

Literatura de apoio: a pesquisa Nacer no Brasil (Leal et al., 2014, 2017; Domingues et al., 2014) consolidou a base empírica sobre adequação do pré-natal, taxas de cesariana e desigualdades raciais; estudos posteriores reforçaram esses achados com recortes específicos (Almeida-Filho et al.; Alves et al., 2020 sobre boas práticas na Rede Cegonha). Sobre violência obstétrica, a revisão integrativa de Zanardo et al. (2017, Psicologia & Sociedade) e o estudo de Lima, Lyra & Pimentel (2021, Ciência & Saúde Coletiva) sobre disparidades raciais na violência obstétrica oferecem síntese atualizada.

Literatura que tensiona ou matiza: a interpretação dos diferenciais raciais nas taxas de cesariana é objeto de disputa metodológica: enquanto a leitura predominante atribui as menores taxas em mulheres negras a barreiras de acesso (Leal et al., 2017), parte da literatura aponta que a interpretação requer estratificação por risco obstétrico real e tipo de financiamento, sob risco de comparações enviesadas (Marmitt et al. sobre Rio Grande do Sul). Sobre adequação do pré-natal, há controvérsia sobre o critério de "cuidado adequado" usado em diferentes estudos.

Em aberto no debate atual: qual o impacto efetivo da pandemia de Covid-19 sobre os indicadores obstétricos brasileiros (a Razão de Mortalidade Materna saltou de 55,3 em 2019 para 107,5 em 2021, segundo o Observatório Obstétrico Brasileiro citado pela UNFPA Brasil); como medir adequadamente a recuperação pós-pandemia; e qual a relação causal entre indicadores de pré-natal e desfechos perinatais quando controlados para determinantes sociais.

3. Histórico das políticas reformistas brasileiras: PAISM, Rede Cegonha, Rede Alyne

A palestrante revisita criticamente três marcos: a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que introduziu olhar para a saúde sexual e reprodutiva mas não modificou indicadores; a Rede Cegonha (2011), que avançou com Centros de Parto Normal e foi sustentada, em sua avaliação, sobretudo pelo trabalho de enfermeiras obstétricas e obstetrizes; e a Rede Alyne (2024), que retoma a agenda mas, em sua leitura crítica, "falha quando não aponta a enfermeira obstétrica ou obstetriz como figura central dessa mudança de modelo".

A leitura é a de uma sequência de tentativas insuficientes — "a gente começou a olhar diferente, mas a gente não mudou o indicador". A inferência política é a de que reformas sem deslocamento da centralidade médico-hospitalar tendem a esgotar-se em redesenhos de fluxo sem mudança de paradigma. A Rede Alyne, lançada em 2024 com investimento previsto de R\$ 400 milhões em 2024 e R\$ 1 bilhão em 2025, é o teste atual dessa hipótese.

Mapa de evidências

Afirmação central da palestra: as redes brasileiras de atenção materna até hoje não conseguiram modificar significativamente os indicadores porque não deslocaram a centralidade do modelo médico-hospitalar.

Literatura de apoio: avaliações da Rede Cegonha (Avaliação da Rede Cegonha, 2019, citada no Manifesto; Bittencourt et al., 2014) reconhecem avanços parciais sem mudança estrutural de indicadores; estudos sobre Centros de Parto Normal peri-hospitalares (Aguar et al., 2025, Cad Saúde Pública) mostram que estes serviços, quando funcionam, alcançam 96,9% de partos por enfermeiras/obstetrizes e 0,4% de episiotomia — desempenho fortemente alinhado às boas práticas, mas representando proporção marginal dos partos do país.

Literatura que tensiona ou matiza: há divergência sobre a atribuição causal: parte da literatura (Domingues et al., Cad Saúde Pública) atribui os limites da Rede Cegonha à descontinuidade política após 2016, não ao desenho do modelo; outras leituras (Diniz et al.) destacam a ausência de mecanismos coercitivos de regulação da saúde suplementar como fator determinante. Sobre a Rede Alyne, é cedo para avaliação

consolidada — sua implementação está em curso e estudos avaliativos só serão publicados nos próximos anos.

Em aberto no debate atual: qual o desenho institucional capaz de sustentar reformas obstétricas no Brasil ao longo de transições governamentais; como avaliar comparativamente Rede Cegonha e Rede Alyne controlando o efeito da pandemia; e qual a relação entre investimento financeiro (cobertura de procedimentos) e mudança de modelo (cultura institucional, formação, regulação).

4. Modelos internacionais como repertório de transição

A palestra apresenta cinco modelos extraídos do guia de implementação da OMS (2025): continuidade de cuidado pela enfermeira obstétrica e obstetriz (Nova Zelândia), modelo baseado na comunidade (Senegal), centro de parto, prática privada integrada (Uganda) e modelo de cenário humanitário de crise. O argumento central não é que algum desses modelos deva ser adotado integralmente no Brasil, mas que todos compartilham um princípio comum — coordenação por parteiras com decisão autônoma e colaboração com outros profissionais — e que esse princípio é o que precisa ser brasileiro em arranjos regionais diversificados.

Operação intelectual relevante: a palestrante propõe modelos regionalizados em vez de modelo único, antecipando crítica frequente de transposição cultural acrítica. Esse movimento dialoga com a literatura sobre adaptação de evidência a contextos de baixa e média renda (LMICs), que enfatiza a necessidade de design contextual sensível.

Mapa de evidências

Afirmação central da palestra: o consenso internacional valida o modelo coordenado por enfermeiras obstétricas e obstetrizes, e arranjos regionalizados podem viabilizar sua implementação no Brasil.

Literatura de apoio: a metanálise Cochrane mais recente (Sandall et al., 2024) confirma benefícios consistentes de modelos de continuidade de cuidado por parteiras: redução de cesarianas, intervenções, partos prematuros (RR 0,76, IC95% 0,64-0,91 para parto pré-termo), com desfechos perinatais comparáveis. A Lancet Series on Midwifery (Renfrew et al., 2014; ten Hoope-Bender et al., 2014) sustenta que profissionais de

obstetrícia podem cobrir até 90% das necessidades essenciais em saúde sexual, reprodutiva, materna, neonatal e adolescente. A revisão de escopo de Bradford et al. sobre 91 anos de experiências de continuidade em LMICs reporta reduções de 16% em perdas neonatais e 24% em prematuridade.

Literatura que tensiona ou matiza: a maior parte das evidências é gerada em países de alta renda com sistemas de saúde diferentes do brasileiro (Sandall et al., 2024 explicitam essa limitação); estudos qualitativos com parteiras em sistemas integrados (Reiger; Skinner & Foureur) apontam fenômenos de "deprofissionalização" e "practicing down" quando modelos colaborativos são implementados sem proteção do escopo de prática. A própria revisão Cochrane classifica vários desfechos como "evidência de muito baixa certeza" para resultados específicos como morte materna (não houve mortes maternas em três estudos, amostra insuficiente).

Em aberto no debate atual: qual a transposição empiricamente válida desses modelos para o SUS, considerando as desigualdades regionais; como construir sistemas de transferência seguros entre comunidade/CPN e hospital de referência (a palestrante reconhece que "esse é um grande nó no Brasil"); e qual o desenho de remuneração na saúde suplementar que viabilize esses modelos.

5. Centralidade da enfermagem obstétrica e da obstetriz como liderança do cuidado

Esta é a tese mais identitária da palestra: o modelo brasileiro só se reformará se as enfermeiras obstétricas e obstetrizes assumirem a liderança do cuidado nos partos de risco habitual. A formulação operacional é precisa: coordenação autônoma do cuidado em todo o escopo de prática, com colaboração efetiva com obstetras, pediatras e outros especialistas via consultas e encaminhamentos. A justificativa é bifronte — empírica (países com melhores indicadores adotam esse modelo) e fisiológica (a parteira é, por formação, a profissional centrada na fisiologia do parto).

No plano regulatório brasileiro, a Resolução COFEN nº 737/2024 — alterada pela 786/2025 — formalizou parâmetros para atuação privativa de enfermeiros obstétricos e obstetrizes no parto domiciliar planejado, marco recente que opera como base

normativa para a expansão dessa autonomia. A relação dessa normatização com a oferta de serviços credenciados pela ANS é, segundo a literatura, ainda incipiente.

Mapa de evidências

Afirmação central da palestra: o cuidado obstétrico liderado por enfermeiras obstétricas e obstetrizas pode evitar grande proporção de mortes maternas e neonatais e melhorar substancialmente desfechos.

Literatura de apoio: estimativa do State of the World's Midwifery (Nove et al., 2021) de que o financiamento integral do cuidado liderado por parteiras até 2035 poderia evitar 67% das mortes maternas, 64% das mortes neonatais e 65% dos natimortos; estudo de Vedam et al. (2018, PLoS One) mapeando integração de parteiras nos 50 estados dos EUA encontrou correlação positiva entre maior integração e melhores desfechos (taxa de cesariana, prematuridade, baixo peso, morte neonatal); revisão Cochrane 2024 (Sandall et al.) sustenta benefícios consistentes em desfechos secundários e satisfação materna.

Literatura que tensiona ou matiza: literatura sobre "midwifery integration" enfatiza que os benefícios dependem de condições regulatórias e organizacionais específicas — autonomia de prática, financiamento adequado, governança colaborativa. Estudos qualitativos (Smith DC, J Midwifery Womens Health, 2015) sobre o framework colaborativo em quatro dimensões (organizacional, processual, relacional, contextual) apontam que sem estas condições os benefícios não se materializam, podendo até inverter-se. No Brasil, dados do SINASC indicam que 30% dos partos normais foram assistidos por enfermeiras em 2024, com forte variação por município — em São Paulo capital chegou a 53,7%, no interior de muitos estados é abaixo de 5%.

Em aberto no debate atual: qual a relação dose-resposta entre cobertura de cuidado por enfermeira obstétrica e desfechos populacionais brasileiros; qual o impacto da Resolução COFEN 737/2024 sobre a oferta efetiva de parto domiciliar planejado e sua eventual incorporação à saúde suplementar; e como avaliar metodologicamente a qualidade do cuidado por enfermagem obstétrica em diferentes arranjos institucionais.

6. Determinantes sociais e iniquidades raciais

Atravessando todo o argumento, a palestrante mobiliza recorrentemente o recorte racial: 74% das gestações em mulheres negras não foram planejadas; mortalidade materna em mulheres negras é o dobro da média geral (110,6 por 100.000 nascidos vivos contra 57,7 no agregado nacional, dados de 2022 citados pelo Ministério da Saúde no lançamento da Rede Alyne); apenas 8% das mulheres negras recebem cuidados pré-natais adequados; mulheres negras são a maioria das vítimas de violência obstétrica.

A leitura proposta é estrutural: esses diferenciais não são produto de fatores comportamentais ou biológicos, mas manifestação direta de racismo institucional na saúde. A meta governamental específica de reduzir em 50% a mortalidade materna em mulheres pretas até 2027 — explícita na Rede Alyne — reconhece esse diagnóstico em chave de política pública.

Mapa de evidências

Afirmação central da palestra: os indicadores obstétricos brasileiros são profundamente atravessados por iniquidades raciais que se manifestam em todos os pontos da atenção e demandam abordagem específica.

Literatura de apoio: estudos da equipe Nacer no Brasil (Domingues et al., 2014; Leal et al., 2017) documentam consistentemente piores indicadores de pré-natal, parto e desfechos em mulheres negras; revisão integrativa sobre violência obstétrica em mulheres negras (Lima et al., 2021, Ciência & Saúde Coletiva) sintetiza a evidência em perspectiva interseccional; Souza & Gallo (2022, Rev Panam Salud Pública) trazem síntese sobre iniquidades raciais na mortalidade materna; o Painel de Monitoramento da Mortalidade Materna do Ministério da Saúde fornece dados desagregados continuamente.

Literatura que tensiona ou matiza: leituras críticas (parte da literatura sobre racismo obstétrico) apontam que o foco em indicadores agregados pode obscurecer a heterogeneidade dentro do grupo "mulheres negras" — diferenças entre mulheres pretas e pardas, urbanas e rurais, regionais. Outras leituras enfatizam que indicadores melhores que a média entre brancas (taxa de cesárea menor, por exemplo) podem refletir não privilégio mas barreiras de acesso, demandando interpretação cuidadosa.

Há também debate sobre a categoria "racismo obstétrico" como conceito analítico ou como descrição empírica.

Em aberto no debate atual: desenhos de intervenção empiricamente validados para reduzir as iniquidades raciais brasileiras (faltam ensaios pragmáticos com este desfecho específico); como articular meta de redução de 50% (Rede Alyne) com mecanismos de acreditação hospitalar que incluam equidade racial como indicador; e como mensurar adequadamente o racismo institucional nos serviços brasileiros.

7. Articulação política do movimento reformista atual

A palestra documenta detalhadamente a articulação política em curso: entrega do manifesto ao Ministro da Saúde Alexandre Padilha em 2025, com compromisso ministerial de criação de grupo de trabalho dentro do Comitê de Mortalidade Materna; audiência pública na Câmara dos Deputados (proposta pela deputada Ana Paula Lima); endosso do COFEM ao manifesto; protocolo no Conselho Nacional de Saúde; conferência livre na Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres; engajamento da SGTES/MS para a formação de 750 novos especialistas em enfermagem obstétrica; petição internacional da ICM por mais de um milhão de parteiras no mundo.

Operação política bem articulada: o movimento mobiliza simultaneamente os três poderes (executivo via MS, legislativo via audiência pública, e — implicitamente — judiciário via casos paradigmáticos como Alyne Pimentel), múltiplas instâncias federativas (CNS, CIT), e amplo arco de aliados (entidades feministas, conselhos profissionais, universidades). Para o pesquisador, a palestra funciona como mapa atualizado da geografia política do movimento.

Mapa de evidências

Afirmação central da palestra: há janela política aberta para a Reforma Obstétrica no Brasil, com configuração de forças favorável e mobilização institucional crescente.

Literatura de apoio: documentação institucional disponibilizada pelo COFEN (notas oficiais sobre audiências e endossos), pela Rede Feminista de Saúde (publicação do Manifesto atualizado, fev. 2025) e pelo Ministério da Saúde (lançamento da Rede Alyne,

set. 2024) confirmam o conjunto de eventos descritos. A petição da ICM e o lançamento do Implementation Guidance da OMS (2025) corroboram o alinhamento internacional.

Literatura que tensiona ou matiza: literatura sobre ciclos de reforma em saúde no Brasil (Paim, J. S. e a tradição da Reforma Sanitária) sugere que janelas políticas são instáveis e que reformas dependem de coalizões duradouras, não apenas de momentos de oportunidade. Análises sobre a relação entre advocacy de categorias profissionais e ampliação de escopo (ex.: enfermagem na atenção básica) mostram que avanços normativos podem não se traduzir em mudanças efetivas de prática sem investimento simultâneo em formação e regulação.

Em aberto no debate atual: qual a sustentabilidade da janela política em diferentes cenários eleitorais; como medir empiricamente o avanço do movimento (que indicadores de processo seriam adequados); e qual o papel da saúde suplementar e da ANS na configuração futura — historicamente o “elefante na sala” do debate, dado que cesarianas eletivas são produto rentável.

8. Formação profissional, autonomia regulatória e força de trabalho

Por fim, a palestra articula reforma assistencial com reforma da força de trabalho: formação ampliada de enfermeiras obstétricas e obstetrizes, autonomia regulatória plena e ambientes legais favoráveis. O dado citado pela presidente da ABENFO em outras intervenções públicas (e contextualmente pertinente) é que países com bons indicadores obstétricos têm em média 55 especialistas para cada mil nascidos vivos; o Brasil tem cerca de 5. A meta da SGTES/MS é formar 750 novos especialistas em enfermagem obstétrica — número significativo no agregado, mas modesto frente ao gap estrutural.

A palestrante adverte explicitamente: “não adianta só a gente formar esses enfermeiros, mas eles têm que ter campo de trabalho, eles têm que ser reconhecidos como tal, eles têm que ter autonomia como tal”. Formulação que, do ponto de vista da literatura sobre integração da força de trabalho, é precisa: oferta de profissionais sem condições efetivas de prática produz subutilização, frustração de carreira e migração para outras áreas.

Mapa de evidências

Afirmção central da palestra: a viabilidade da Reforma Obstétrica depende simultaneamente de formação ampliada, autonomia regulatória plena e ambiente institucional que permita exercício efetivo do escopo de prática.

Literatura de apoio: o State of the World's Midwifery 2021 (Nove et al.) documenta o déficit global de 900 mil parteiras e detalha quatro dimensões necessárias para o impacto: educação, regulação, deployment e management. Vedam et al. (2018) operacionalizaram o conceito de midwifery integration em 50 estados dos EUA, demonstrando correlação com desfechos. A revisão de Goodarzi et al. (2022) na Holanda detalha como o desenho organizacional define a divisão de tarefas entre parteiras e obstetras de forma efetiva.

Literatura que tensiona ou matiza: literatura sobre "task shifting" em saúde (especialmente em LMICs) destaca que ampliação de escopo profissional sem redes de suporte adequadas pode comprometer segurança e qualidade. Estudos críticos sobre integração colaborativa (Reiger; Hutchison et al.) apontam fenômenos de pressão para "practicing down" — quando parteiras em contextos hospitalares acabam exercendo prática mais medicalizada do que sua formação preconiza, por pressão organizacional. Análises sobre formação em enfermagem obstétrica no Brasil (artigos em Texto & Contexto Enfermagem, Esc Anna Nery) discutem tensões entre formação técnica e prática efetiva nos serviços.

Em aberto no debate atual: qual o tamanho de força de trabalho necessário para o cenário brasileiro real, considerando heterogeneidade regional; qual o tempo necessário para que aumento de oferta de profissionais se traduza em mudança de indicadores populacionais; e qual a contribuição relativa de cada componente (formação, regulação, deployment, gestão) para o impacto esperado.

Configuração de Forças no Campo Acadêmico

Escolas, grupos de pesquisa, agências e periódicos relevantes

Diferentemente da seção homóloga do perfil Pleno, que mapeia atores políticos e corporativos, esta seção lê o campo do ponto de vista da produção de conhecimento. Para o pesquisador, importa saber quais grupos pesquisam o tema, em que tradições teóricas se inscrevem, quais agências financiam a área e em que periódicos a produção circula. Mapa não exaustivo, mas suficiente para orientar entrada do leitor que queira aprofundar em qualquer dos eixos da palestra.

Grupos de pesquisa brasileiros consolidados

Grupo / Programa	Instituição	Eixo principal
Equipe Nascer no Brasil (Maria do Carmo Leal e equipe)	ENSP/Fiocruz	Epidemiologia perinatal de base populacional, desigualdades raciais
Observatório Obstétrico Brasileiro (Rossana Francisco)	USP / Fiocruz	Monitoramento de indicadores em tempo real, séries temporais
Sentidos do Nascer (Sônia Lansky)	UFMG	Sociologia da experiência do parto, violência obstétrica
Programa de Pós em Enfermagem Obstétrica	EE-USP / EERP-USP	Avaliação de modelos, formação, prática baseada em evidência
NUPESC / Vigilância em Saúde Materna	IFF/Fiocruz	Mortalidade materna, vigilância epidemiológica
Núcleo de Estudos das Desigualdades e Relações de Gênero	UERJ	Direitos humanos e saúde, perspectiva de gênero
Grupo de Estudos sobre Parto Domiciliar	UFSC / UFRJ	Evidências e regulação do parto domiciliar planejado

Agências de fomento e linhas de financiamento

- Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT/MS) — financia pesquisas estratégicas em saúde da mulher; foi a base para a estruturação do Nascer no Brasil II e mantém editais regulares para avaliação de redes assistenciais.
- CNPq — chamadas universais e linhas temáticas em saúde materno-infantil; bolsas de produtividade concentradas em alguns dos grupos listados acima.
- CAPES — programas de pós-graduação em enfermagem com nota 6/7 (USP, UFMG, UFSC, UNIFESP, UFC, entre outros); editais PROEX e PrInt em saúde coletiva.
- FAPESP, FAPERJ, FAPEMIG e demais FAPs — apoio regional, particularmente relevante para grupos consolidados em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
- Agências internacionais — UNFPA Brasil tem sido financiador-articulador de relatórios e estudos avaliativos; OPAS/OMS apoia pesquisas regionais sobre saúde materna; Wellcome Trust e Bill & Melinda Gates Foundation (esta financiou a Lancet Series 2014).

Periódicos onde a produção circula

- **Indexados internacionais (Scopus / WoS):** The Lancet, BMJ Global Health, BMC Pregnancy and Childbirth, Midwifery, Women and Birth, Journal of Midwifery & Women's Health, Birth, International Journal of Gynecology & Obstetrics, Reproductive Health, Human Resources for Health, PLoS ONE.
- **Brasileiros indexados (SciELO / Scopus):** Cadernos de Saúde Pública, Ciência & Saúde Coletiva, Revista de Saúde Pública, Revista Brasileira de Enfermagem, Texto & Contexto Enfermagem, Escola Anna Nery, Revista Latino-Americana de Enfermagem, Revista da Escola de Enfermagem da USP, Revista Panamericana de Salud Pública.
- **Especializados em humanização e direitos:** Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, Saúde em Debate, Interface — Comunicação, Saúde, Educação.

Tradições teóricas em diálogo

Cinco tradições teóricas atravessam o campo e dialogam com a palestra. A primeira é a saúde coletiva latino-americana (Almeida-Filho, Buss & Pellegrini Filho, Paim) — base

para a leitura estrutural dos determinantes sociais. A segunda é a sociologia do parto e da medicalização (Diniz, Tornquist, Tesser) — base para análise do modelo hospitalocêntrico. A terceira é a tradição feminista da saúde reprodutiva (Corrêa, Silva, Pena) — base para a gramática dos direitos. A quarta é o paradigma midwifery model of care (Renfrew, Sandall, ten Hoope-Bender) — base para a proposta técnica internacional. A quinta é a tradição da Reforma Psiquiátrica brasileira (Amarante, Delgado) — base para a analogia paradigmática.

Notar essas filiações é útil porque revela onde o debate está consolidado e onde permanece em tensão. A palestra articula as cinco em registro pragmático, sem necessariamente endereçar suas tensões internas — o que é objeto legítimo da análise acadêmica posterior.

Diálogo Internacional

Como a literatura global conversa com o argumento da palestra

A força argumentativa da palestra deriva, em parte, da convergência internacional sobre o tema. Esta seção sintetiza onde o consenso global é robusto e onde permanece com tensões internas relevantes para a transposição ao contexto brasileiro.

Pontos de convergência consolidada

O paradigma do midwifery model of care goza, na literatura indexada da última década, de robusto suporte empírico. A meta-análise Cochrane atualizada em 2024 (Sandall et al., 17 ensaios, 18.533 mulheres) sustenta benefícios consistentes em desfechos secundários — menos cesarianas, menos partos instrumentais, menos analgesia regional, mais partos vaginais espontâneos — sem prejuízo de desfechos primários de segurança. A Lancet Series on Midwifery (2014) com seu Quality Maternal and Newborn Care Framework estabelece o referencial conceitual; o State of the World's Midwifery 2021 traz a base de dados sobre força de trabalho global; e o Global Position Paper da OMS (2024) com o Implementation Guidance (2025) fornece diretrizes operacionais. A convergência ICM-WHO-UNFPA-UNICEF é visível e atual.

Pontos de tensão e debate aberto

A literatura mais recente vem destacando, contudo, dimensões que a leitura entusiástica do paradigma tende a obscurecer. Primeiro, há a questão da generalização: a maior parte das evidências da Cochrane vem de países de alta renda — Reino Unido, Austrália, Irlanda, Canadá, Nova Zelândia — com sistemas de saúde, força de trabalho e regulação muito diferentes do brasileiro. A própria revisão Cochrane (Sandall et al., 2024) reconhece essa limitação e classifica grande parte dos desfechos secundários como "evidência de baixa ou muito baixa certeza".

Segundo, há a tensão entre integração e autonomia. Estudos qualitativos (Reiger, Skinner & Foureur, Smith DC, 2015) apontam que sistemas que integram parteiras em ambientes hospitalares podem produzir efeito paradoxal de "deprofissionalização", com parteiras pressionadas a "practicing down" — exercer prática mais medicalizada do

que sua formação preconiza. Esta literatura pede design organizacional cuidadoso, não apenas inserção formal.

Terceiro, há o debate sobre a aplicabilidade ao parto domiciliar. A revisão Cochrane explicitamente exclui da análise primária ensaios sobre parto domiciliar planejado, área onde a evidência é menos robusta e mais controversa internacionalmente. No Brasil, com a Resolução COFEN 737/2024, esta é fronteira regulatória ativa.

Quarto, há tensões raciais específicas a contextos como Brasil e EUA. O cuidado por parteiras é apresentado, em parte da literatura norte-americana, como estratégia para reduzir desigualdades raciais em desfechos maternos (Vedam et al., 2018). Mas estudos críticos (incluindo a tradição de "obstetric racism" de Davis nos EUA) advertem que a implementação ingênua do modelo, sem enfrentamento explícito do racismo estrutural na formação e na prática, pode reproduzir as mesmas desigualdades.

O que importa adaptar criticamente para o Brasil

Da síntese, três pontos merecem atenção do pesquisador brasileiro. Primeiro, o desenho de estudos avaliativos brasileiros que estabeleçam evidência local sobre cobertura e desfecho — não basta importar evidência de países nórdicos para sustentar política nacional. Segundo, o desenho institucional dos modelos de transição precisa contemplar a especificidade do SUS (descentralização federativa, heterogeneidade regional) e da saúde suplementar (lógica de mercado, papel da ANS). Terceiro, o enfrentamento explícito do racismo institucional precisa estar incorporado ao design, não como "consideração de equidade" pendurada ao final, mas como princípio organizador.

Mapa de Tensões e Debates Abertos

O que está efetivamente em disputa, e o que a palestra resolve, desloca ou contorna

Toda palestra mobilizadora opera seleções — destaca o que ajuda o argumento e atravessa rapidamente o que complicaria. Para o leitor pesquisador, vale explicitar essas seleções, não em chave de denúncia, mas em chave de mapeamento do que permanece como objeto de pesquisa.

Tensão / Debate	Como a palestra trata	O que permanece em aberto
Modelo único vs. arranjos regionais	Adota explicitamente a posição "modelos regionalizados"	Que critérios usar para definir arranjos por região, e como evitar fragmentação
Integração colaborativa vs. autonomia plena	Articula os dois conceitos sem tematizar a tensão	Como desenhar protocolos institucionais que protejam a autonomia em ambientes hospitalares
Saúde suplementar e cesarianas	Mencionada brevemente; ANS não é adversário central	Quais incentivos econômicos podem reorientar o modelo na saúde privada
Parto domiciliar planejado	Defendido como direito regulamentado	Quais as condições de segurança e o desenho de transferência intra-parto no contexto brasileiro
Recorte racial: barreira ou privilégio	Lido como barreira de acesso (taxa menor de cesárea em negras)	Como interpretar esses diferenciais em estratos de risco e financiamento
Avaliação da Rede Cegonha	Reconhece avanços, mas atribui sustento às enfermeiras	Análise comparativa controlando contexto político de pós-2016
Universidades e formação	Demanda expansão de oferta	Como articular formação acelerada (SGTES) com

Tensão / Debate	Como a palestra trata	O que permanece em aberto
		qualidade de pós-graduação stricto sensu
Relação ABENFO-COFEN-FEBRASGO-CFM	Foca alianças, sinaliza apoio do COFEN	Como operam as resistências corporativas e o que viabiliza pactuação
Reforma Psiquiátrica como modelo	Mobilizada como analogia inspiradora	O que efetivamente foi alcançado e o que permanece incompleto na Reforma Psiquiátrica brasileira

Tensões internas ao próprio paradigma midwifery model of care

Mesmo dentro do paradigma defendido pela palestra, há controvérsias internas que merecem registro. A primeira é entre quem defende continuidade de cuidado por uma única parteira (modelo neozelandês) e quem defende continuidade por equipe pequena (modelos britânicos), com implicações sobre escala e custo. A segunda é sobre o papel da formação direta (obstetriz) versus indireta (enfermeira obstétrica especializada) — debate ativo na ICM e que tem implicações para as políticas brasileiras de formação. A terceira é sobre a relação com doulas e parteiras tradicionais, profissionais não regulamentados que cumprem papel relevante em regiões específicas, especialmente Norte e Nordeste.

Lacunas de Pesquisa Identificáveis

Perguntas que a palestra abre e que poderiam virar projeto, artigo ou tese

Para o pesquisador, a palestra opera como conjunto de hipóteses não totalmente testadas no contexto brasileiro. Esta seção sistematiza, por eixo, lacunas que se prestam a desenhos de pesquisa empírica.

Lacunas em epidemiologia e avaliação

- Quantificação rigorosa do impacto da pandemia de Covid-19 sobre indicadores obstétricos brasileiros, com séries temporais longas e modelos contrafactuais. A literatura tem dados pontuais (UNFPA Brasil, OOBBr); falta avaliação consolidada da recuperação pós-pandemia por estado e por estrato sócio-racial.
- Avaliação comparativa Rede Cegonha vs. Rede Alyne, controlando o efeito do contexto político e da pandemia. A Rede Alyne só permitirá avaliação rigorosa após 2026-2027, mas o desenho da pesquisa avaliativa pode ser publicado já.
- Estudos de coorte brasileiros sobre desfechos de partos assistidos por enfermeiras obstétricas vs. médicos, em diferentes níveis de risco e cenários institucionais (UBS, hospital, CPN, domiciliar planejado), com ajuste apropriado para confundimento.
- Estudos econômicos de avaliação de custo-efetividade dos diferentes arranjos institucionais brasileiros — gap relevante para influenciar a ANS e as gestões municipais de SUS.

Lacunas em desigualdades raciais

- Mensuração empírica da operação do racismo institucional na assistência obstétrica brasileira, com instrumentos validados localmente. A categoria "racismo obstétrico" está consolidada conceitualmente; faltam medidas operacionais robustas.
- Heterogeneidade dentro do grupo "mulheres negras": diferenciais entre mulheres pretas e pardas, urbanas e rurais, regionais. A literatura tem trabalhado com agregação que pode obscurecer fenômenos importantes.

- Desenhos de intervenção para reduzir iniquidades raciais em desfechos maternos brasileiros, com avaliação rigorosa. Ensaios pragmáticos com este desfecho específico são raros no país.

Lacunas em sociologia do movimento e implementação

- Análise sociológica do movimento pela Reforma Obstétrica como movimento de saúde — coalizão, repertório de ação coletiva, estratégias retóricas, resultados políticos. Há base teórica robusta na literatura sobre Reforma Sanitária para articular essa análise.
- Estudos qualitativos sobre a implementação da Resolução COFEN 737/2024 em diferentes contextos territoriais. Como a regulamentação tem sido apropriada na prática? Quais as redes de transferência intra-parto efetivamente estabelecidas?
- Etnografia das resistências corporativas — como FEBRASGO, CFM, parte das operadoras de saúde mobilizam argumentos contra a expansão do escopo das enfermeiras obstétricas. Análise menos tributária da chave da disputa, mais atenta à estrutura argumentativa de cada lado.

Lacunas em formação e força de trabalho

- Avaliação do impacto da formação acelerada (programa SGTES de 750 especialistas) sobre desfechos populacionais, com horizonte de 5 a 10 anos.
- Análise comparativa do percurso formativo via residência em enfermagem obstétrica vs. especialização lato sensu, com indicadores de prática efetiva e satisfação profissional.
- Estudos sobre evasão profissional na enfermagem obstétrica brasileira — quantos especialistas formados estão efetivamente exercendo a especialidade, em que cenários, e por que a evasão.

Agenda de Pesquisa Futura

Direções metodológicas, hipóteses testáveis, desenhos plausíveis

Esta seção converte as lacunas mapeadas em provocações de pesquisa, com sugestões de desenho metodológico. Não há intenção de exaustividade — são pontos de entrada para quem quer ancorar trabalho próprio nas questões abertas pela palestra.

Estudos quantitativos de base populacional

Em primeiro lugar, há ampla margem para coortes nacionais que articulem dados do SINASC, do SIM e do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) para mapear cobertura de cuidado por enfermagem obstétrica no Brasil, com série temporal e cruzamentos por município, perfil de financiamento e perfil sócio-racial. O Observatório Obstétrico Brasileiro já oferece infraestrutura para este tipo de análise; faltam estudos publicados sistematicamente. Hipótese testável: municípios com maior cobertura de partos assistidos por enfermeiras obstétricas apresentam, controlando para confundidores, desfechos maternos e neonatais melhores que municípios comparáveis com menor cobertura.

Em segundo lugar, o desenho de uma pesquisa avaliativa da Rede Alyne, com janela de seguimento até 2030, é prioridade. A literatura sobre avaliação de redes assistenciais (Hartz, Felisberto, e a tradição da avaliação em saúde brasileira) oferece arcabouço metodológico consolidado. O desenho ideal articularia componentes quantitativos (séries temporais interrompidas, comparação entre estados aderentes e não-aderentes) e qualitativos (estudos de implementação em casos selecionados).

Estudos de implementação e desenho institucional

A literatura sobre implementation science oferece arcabouço conceitual relevante para estudar a transposição do midwifery model of care ao contexto brasileiro. Frameworks como o CFIR (Consolidated Framework for Implementation Research) e o RE-AIM podem orientar estudos sobre como Centros de Parto Normal, equipes de parto domiciliar planejado e sistemas de continuidade de cuidado são efetivamente implementados — incluindo barreiras, facilitadores e adaptações locais.

Hipótese testável: a sustentabilidade de Centros de Parto Normal no Brasil depende criticamente da articulação com hospital de retaguarda em três dimensões — clínica (protocolo de transferência), organizacional (governança compartilhada) e política (apoio municipal). Estudos de caso comparativos entre CPNs sustentáveis (Sofia Feldman, Realengo) e CPNs descontinuados podem operacionalizar esse desenho.

Estudos qualitativos e etnográficos

Há terreno especialmente fértil para etnografia da prática profissional — observação participante em serviços com diferentes configurações (hospital convencional, CPN intra-hospitalar, CPN peri-hospitalar, parto domiciliar planejado). Estudos como os de Diniz, Tornquist e Tesser estabelecem tradição metodológica robusta nesse terreno. Hipótese: a fronteira entre prática medicalizada e prática centrada na fisiologia é mais sensível ao desenho organizacional do serviço do que à formação individual da profissional.

Outro recorte qualitativo promissor é a análise sociotécnica do movimento pela Reforma Obstétrica como movimento social — entrevistas com lideranças, análise documental do Manifesto e de seus desdobramentos, mapeamento de coalizões. A literatura sobre advocacy em saúde pode orientar essa abordagem.

Estudos em desigualdades raciais

A construção de instrumentos validados para mensurar racismo institucional na assistência obstétrica brasileira é prioridade. A tradição de psicometria em saúde da mulher (escalas de violência obstétrica, de empoderamento materno) oferece base metodológica; faltam adaptações ou construções específicas para o eixo racial. Hipótese testável: o racismo institucional na assistência obstétrica opera por mecanismos identificáveis e mensuráveis (peregrinação, comunicação assimétrica, manejo da dor diferenciado, restrição ao acompanhante) que podem ser captados em instrumentos validados.

Pesquisa-ação em parceria com movimentos de mulheres negras (Rede Feminista de Saúde, Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras, ReUna) pode articular produção de conhecimento com transformação de prática — modelo já experimentado em outras áreas da saúde coletiva brasileira.

Estudos econômicos e de financiamento

Avaliações econômicas de custo-efetividade comparando arranjos assistenciais — parto hospitalar tradicional, CPN intra-hospitalar, CPN peri-hospitalar, parto domiciliar planejado — são gap relevante na literatura brasileira. A Cochrane Review 2024 sugere economia de custos no cuidado por parteiras em países de alta renda, mas a transposição requer dados brasileiros. Estudos como o de Campos, Rattner & Diniz (2024, Cad Saúde Pública) sobre o Programa Parto Adequado da ANS oferecem modelo metodológico para análises comparativas.

Implicações para Formação e Currículo

O que muda na graduação, na pós e na formação continuada

Para o leitor docente e pesquisador, esta seção mapeia o que decorre da Reforma Obstétrica no plano da formação acadêmica — distinto, portanto, das “implicações para sua prática profissional” que constituiriam seção análoga no perfil Pleno.

Graduação em Enfermagem

A consolidação do paradigma midwifery model of care e da Resolução COFEN 737/2024 demanda revisão curricular substantiva nos cursos de graduação em Enfermagem, com expansão da carga em obstetrícia (atualmente subdimensionada em muitas IES brasileiras) e incorporação dos eixos de fisiologia do parto, evidência baseada em prática, direitos reprodutivos e racismo obstétrico. A Lancet Series on Midwifery (Renfrew et al., 2014) oferece referência curricular internacional via o Quality Maternal and Newborn Care Framework — pode operar como mapa para revisão de Diretrizes Curriculares Nacionais.

Para a graduação em Medicina, o ponto é mais complexo: a Reforma Obstétrica não pretende eliminar o obstetra, mas reposicioná-lo no cuidado a alto risco e em complicações. Currículos precisariam refletir essa reposicionamento, com formação para colaboração interprofissional (não apenas conteúdo técnico) e para manejo de gestações de alto risco. A literatura internacional sobre formação obstétrica em modelos integrados (estudos da ACOG, da Royal College of Obstetricians and Gynaecologists britânico) oferece referências.

Pós-graduação stricto sensu

Programas de pós-graduação em Enfermagem (e em Saúde Coletiva e Saúde Pública) vivem demanda crescente por pesquisa em saúde materna. As lacunas mapeadas na seção anterior podem orientar editais temáticos, linhas de pesquisa institucionais e seleção de projetos de mestrado e doutorado. A articulação com o Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT/MS), que financia pesquisas estratégicas em saúde da mulher, é caminho institucional.

Há também espaço para programas de Doutorado em Enfermagem Obstétrica especificamente, ainda incipientes no Brasil quando comparados a tradições como Reino Unido, Austrália e EUA. A formação de doutores especialistas é condição estrutural para que a categoria desenvolva pesquisa autônoma e influencie diretrizes baseadas em evidência produzida no contexto brasileiro.

Formação especializada e residências

A meta da SGTES/MS de formar 750 novos especialistas em Enfermagem Obstétrica é movimentação relevante, mas comporta debate sobre desenho. Especialização lato sensu acelerada e Residência em Enfermagem Obstétrica produzem perfis profissionais distintos, com implicações para autonomia de prática e para sustentação na carreira. Pesquisa avaliativa comparando os dois percursos — taxa de retenção na especialidade, indicadores de prática, satisfação profissional, mobilidade institucional — é gap mapeado anteriormente.

Outro ponto é a formação em preceptoria. A expansão de Centros de Parto Normal e do parto domiciliar planejado demanda preceptoras experientes — quadro em formação. Programas de pós-graduação podem incorporar essa dimensão como eixo formativo específico.

Formação continuada

Por fim, a formação continuada das profissionais já atuantes é dimensão crítica. A palestrante mencionou cursos sobre Implanon na Amazônia como exemplo concreto. A literatura sobre educação permanente em saúde (Ceccim e equipe) oferece arcabouço metodológico para esta dimensão. Vale registrar que a expansão da inserção de DIU por enfermeiras na atenção primária — citada em fontes do COFEN como tendo crescido 147% recentemente — é caso paradigmático de como expansão de escopo regulatório precisa ser acompanhada por formação continuada efetiva.

Bibliografia Complementar

Cinco portas de entrada essenciais para o pesquisador

Curadoria enxuta com as cinco referências mais relevantes para aprofundar o tema, considerando recência, centralidade temática e bibliografias mencionadas pela palestrante. Outras dezenas de referências indexadas aparecem inline ao longo do livebook — em especial nos Mapas de Evidências de cada tópico (Seção 6), no Diálogo Internacional (Seção 8) e na Agenda de Pesquisa Futura (Seção 11). Esta seção concentra-se nas portas de entrada mais produtivas para quem quer construir conhecimento próprio sobre a Reforma Obstétrica.

1. Documento de paradigma — citado pela palestrante

World Health Organization (2024). Transitioning to midwifery models of care: global position paper. Geneva: WHO. ISBN: 9789240098268. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240098268>

Por que ler: é o documento técnico-político central que organiza, em registro internacional consolidado, a defesa da transição para modelos coordenados por enfermeiras obstétricas e obstetrizes. A palestrante menciona explicitamente o “modelo de transição” da OMS e suas recomendações são a referência mais recorrente em sua argumentação. Foi complementado em 2025 pelo Implementation Guidance on Transitioning to Midwifery Models of Care, que detalha operacionalização por país e contém os cinco modelos discutidos na palestra (continuidade neozelandesa, base comunitária senegalesa, centro de parto, prática privada ugandesa, cenário humanitário).

2. Evidência empírica meta-analítica mais atualizada

Sandall, J.; Fernandez Turienzo, C.; Devane, D.; Soltani, H.; Gillespie, P.; Gates, S.; Jones, L. V.; Shennan, A. H.; Rayment-Jones, H. (2024). Midwife continuity of care models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 4, Art. No. CD004667. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004667.pub6>

Por que ler: é a base empírica mais robusta e atual sobre os desfechos do midwifery model of care. Atualizada em abril de 2024, sintetiza 17 ensaios clínicos randomizados

com 18.533 mulheres e fundamenta o argumento técnico de que modelos coordenados por parteiras reduzem cesarianas, intervenções e partos pré-termo, com desfechos perinatais comparáveis. Para o pesquisador, é também referência metodológica útil — explicita os limites de certeza da evidência (vários desfechos classificados como de "baixa ou muito baixa certeza") e os contextos de origem (majoritariamente países de alta renda), o que pede leitura crítica antes da transposição ao SUS.

3. Relatório global sobre força de trabalho — citado pela palestrante

Nove, A.; ten Hoop-Bender, P.; Boyce, M.; Bar-Zeev, S.; de Lerberghe, W.; Mangu, C.; Morrison, J.; Sansom, T.; Bürgin, F.; Goligher, M.; Homer, C. S. E. (2021). The State of the World's Midwifery 2021 report: findings to drive global policy and practice. *Human Resources for Health*, 19, 146. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00694-w>

Por que ler: é o terceiro relatório global da série SoWMy, produzido por UNFPA, OMS e ICM. Documenta o déficit global de 900 mil parteiras e fornece a estimativa que a palestrante cita diretamente — de que o financiamento integral do cuidado liderado por parteiras até 2035 poderia evitar 67% das mortes maternas, 64% das mortes neonatais e 65% dos natimortos (a Luciane menciona "4,3 milhões de vidas todos os anos"). Cobre 194 países e detalha quatro dimensões necessárias para impacto: educação, regulação, deployment e gestão.

4. Base empírica nacional — desigualdades raciais

Leal, M. C.; Gama, S. G. N.; Pereira, A. P. E.; Pacheco, V. E.; Carmo, C. N.; Santos, R. V. (2017). The color of pain: racial inequities in prenatal care and childbirth in Brazil. *Cadernos de Saúde Pública*, 33(Suppl 1), e00078816. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00078816>

Por que ler: é o artigo central da equipe Nacer no Brasil/Fiocruz sobre as iniquidades raciais que a palestrante mobiliza repetidamente (74% de gestações não planejadas em mulheres negras, mortalidade materna duas vezes maior, apenas 8% de adequação do pré-natal). Sustenta empiricamente, com dados primários de 23.894 puérperas em 266 hospitais, a leitura estrutural do racismo institucional na assistência obstétrica brasileira. É ponto de partida obrigatório para qualquer pesquisa que articule Reforma Obstétrica e equidade racial.

5. Documento do movimento — apresentado pela palestrante

Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos; ABENFO Nacional; REHUNA (2025). Manifesto Reforma Obstétrica no Brasil Já! (atualização fev. 2025). Disponível em: <https://www.redesaude.org.br>

Por que ler: é o documento que a Luciane apresentou ao Ministro da Saúde Alexandre Padilha em 2025 e que organiza politicamente o movimento que ela representa. Para o pesquisador, é fonte primária para análise sociológica do movimento reformista brasileiro em curso — com seus três pleitos centrais (inserção de enfermeiras obstétricas e obstetrizes no SUS com atuação longitudinal, fomento à formação especializada, criação de grupo de trabalho no MS), seus 27 apoios institucionais e sua arquitetura argumentativa. Lê-se em complemento aos documentos da OMS para perceber como o paradigma internacional é traduzido em projeto político nacional.

Para aprofundamento adicional em eixos específicos — Reforma Psiquiátrica como analogia teórica (Amarante, Basaglia), modelos colaborativos com framework de quatro dimensões (Smith, 2015), integração da força de trabalho (Vedam et al., 2018), Centros de Parto Normal brasileiros (Aguiar et al., 2025), Programa Parto Adequado/ANS (Campos, Rattner & Diniz, 2024) — as referências aparecem inline nas seções correspondentes, com indicação de DOI e periódico para localização imediata.

Considerações Finais

Síntese, limites do Livebook e indicações para o leitor

A palestra de Luciane D'Avila apresenta, com economia retórica e densidade política, a posição da ABENFO Nacional sobre o que vem sendo nomeado, no Brasil, como Reforma Obstétrica. Para o pesquisador acadêmico, sua contribuição se concentra em três planos: oferece síntese acessível do paradigma midwifery model of care no contexto brasileiro; documenta a configuração política atual do movimento reformista em curso; e materializa a operação retórica de tradução da gramática internacional para o cenário nacional.

O Livebook, por sua vez, mapeou o estado da literatura indexada que sustenta, tensiona ou matiza cada uma das afirmações centrais da palestra, sem emitir veredicto próprio. A escolha por mapear evidências favoráveis e contrárias, em vez de oferecer julgamento crítico do livebook, é deliberada: o pesquisador acadêmico forma a própria avaliação a partir da literatura, e a função do livebook é organizar o panorama, não substituir o julgamento.

Há, contudo, limites importantes que vale explicitar. Primeiro, este livebook é construído a partir de uma transcrição da palestra com loops de transcrição automática (Deepgram) que foram deduplicados, mas que podem ter eliminado nuances específicas das passagens repetidas. Segundo, a bibliografia curada é seleção, não levantamento sistemático — cobre os marcos conceituais e empíricos centrais, mas não esgota a literatura disponível. Terceiro, as lacunas e a agenda de pesquisa propostas refletem leitura particular das questões abertas pela palestra; outros recortes são possíveis e legítimos.

Para o leitor que queira aprofundar, a entrada mais produtiva varia conforme o interesse. Quem busca o paradigma internacional consolidado encontra ponto de partida na Cochrane 2024 (Sandall et al.) e no Global Position Paper da OMS 2024. Quem se interessa pela base empírica brasileira deve mergulhar na produção da equipe Nascer no Brasil (Leal, Domingues e equipe). Quem investiga o quadro teórico subjacente — a analogia com a Reforma Psiquiátrica — encontra em Amarante (1996, 2007) e em Basaglia (1985) os marcos. Quem se aproxima do movimento social pela

reforma deve consultar diretamente o Manifesto e a documentação produzida pela ABENFO, COFEN e Rede Feminista de Saúde. E quem deseja desenhar pesquisa empírica nesse terreno encontra, na seção Lacunas e Agenda de Pesquisa Futura, sugestões operacionais.

Reformas estruturais em sistemas de saúde são processos longos, que se medem em décadas e não em ciclos políticos. A leitura honesta da Reforma Psiquiátrica brasileira — invocada como analogia inspiradora pela palestrante — pondera que conquistas substantivas convivem, ainda hoje, com tensões e retrocessos. Tomar essa lição como parâmetro pode ser, para a Reforma Obstétrica em curso, mais útil do que adotar entusiasmo unilateral. O campo precisa de pesquisa rigorosa, monitoramento crítico e tempo. Esta é a contribuição que o pesquisador acadêmico pode oferecer ao movimento.